

Principes Diagnostiques et Bilan Préthérapeutique en Oncologie

Guide de la démarche clinique : De la suspicion à la décision.

Dr BRAHMIA.A

Pr BENSALÉM.A

Service d'Oncologie Médicale - Didouche Mourad



Oncologie Médicale

Didouche Mourad

Le Diagnostic vs. Le Dépistage

Diagnostic :

Démarche face à un **symptôme d'alerte** pour **affirmer un cancer**.

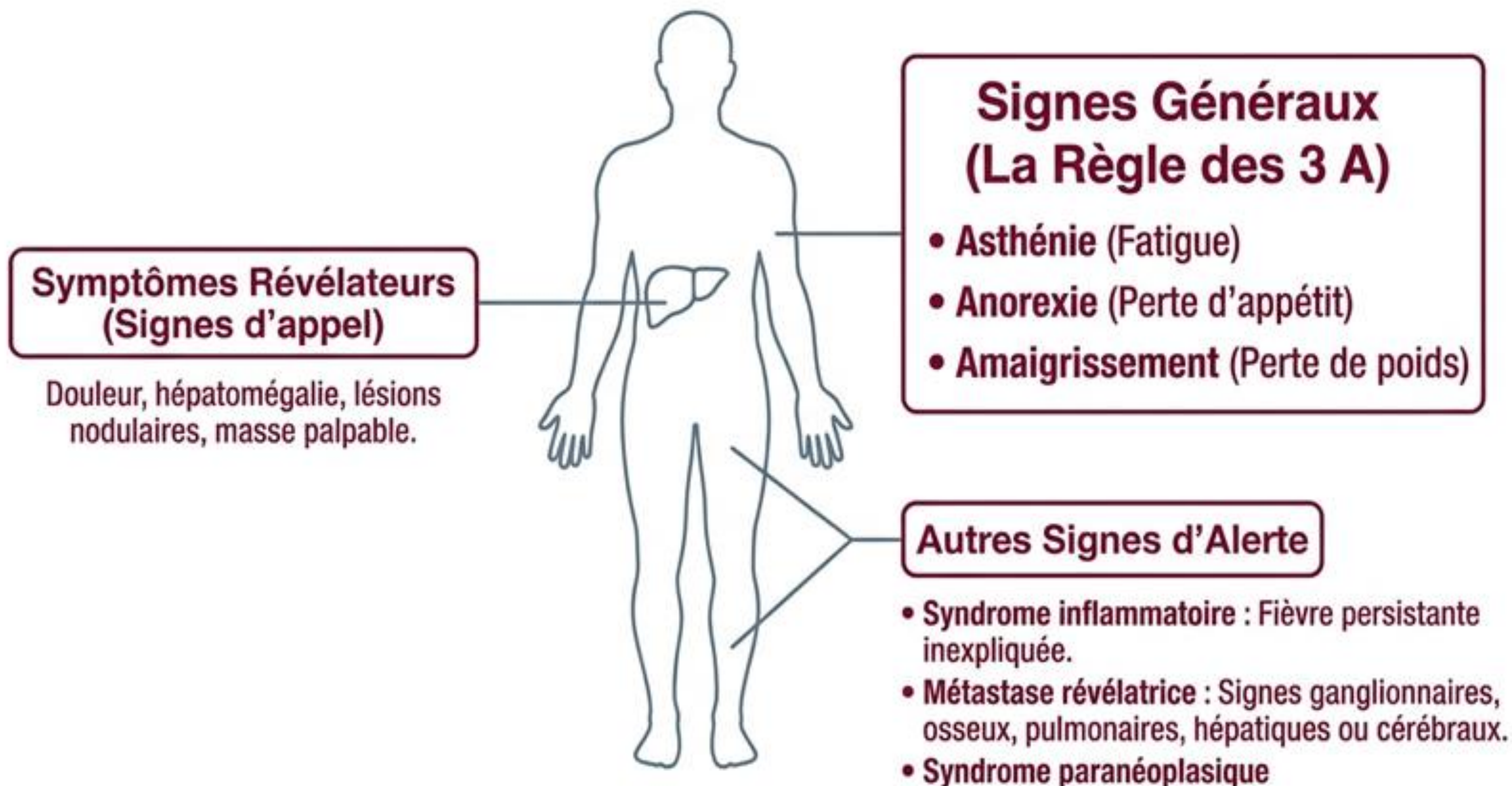
Dépistage :

Recherche d'une tumeur en **absence de symptôme** (sujet à risque).

Les 5 Objectifs du Bilan

- 1  **Rapidité** : Arriver le plus rapidement possible au diagnostic.
- 2  **Certitude : Connaissance histologique précise** (la preuve).
- 3  **Bilan** : Faire le **bilan complet** de la pathologie cancéreuse.
- 4  **Stade** : Définir le **stade (TNM)** à traiter.
- 5  **Décision** : Mettre en route un **projet thérapeutique concerté**.

Diagnostic Positif : Circonstances de Découverte



L'Enquête Clinique : Anamnèse et Examen Physique



1. Anamnèse (Interrogatoire)

- **Histoire de la maladie** : Début, caractère, évolution des symptômes.
- **Antécédents** : Personnels et familiaux.



2. Examen Clinique (Inspection, Palpation, Percussion)

Examen de la zone d'appel :

- Noter la mobilité ou la fixité, l'aspect, mesurer et photographier.

Les territoires ganglionnaires :

- Recherche d'adénopathies (ADP) satellites.

Recherche de métastases :

- Hépatomégalie (HPM), splénomégalie (SPM), épanchement pleural.

Diagnostic Biologique : Orientation et Marqueurs

Note : Les marqueurs sont des éléments d'orientation, pas de preuve formelle.

biologique

Le Bilan Général (Terrain)	Les Marqueurs Tumoraux (Orientation)
• Bilan hépatique • Bilan rénal • Bilan phosphocalcique • Bilan hématologique et LDH	• Ag Onco-fœtaux : ACE, AFP • Ag Spécifiques d'organes : PSA, CA 125, CA 15.3, CA 19.9 • Hormones : HCG, Calcitonine, Thyroglobuline

Associations Évocatrices :

HCG/AFP → Tumeurs germinales / CHC

PSA → Cancer de la prostate

Thyroglobuline (TG) → Cancer différencié de la thyroïde

Imagerie Morphologique : Cartographier la Lésion



1. Radiographie Standard

Mammographie (Sein),
Téléthorax (Poumon),
Os.



2. Échographie

Abdomino-pelvienne.
Permet le guidage pour
biopsies.



3. Scanner (TDM)

Examen clé pour le bilan
d'extension (Thorax,
Abdomen, Pelvis,
Cerveau).



4. IRM (Résonance Magnétique)

Meilleur contraste des
tissus mous.
Extension locale
(Cerveau, Rachis, Pelvis).

Pathology Burgundy
Contre-indication :
Pacemakers, métaux.

Imagerie Fonctionnelle : Activité Métabolique

TEP-Scanner (PET Scan)

Principe : Injection de ^{18}F -FDG (Glucose radiomarqué).

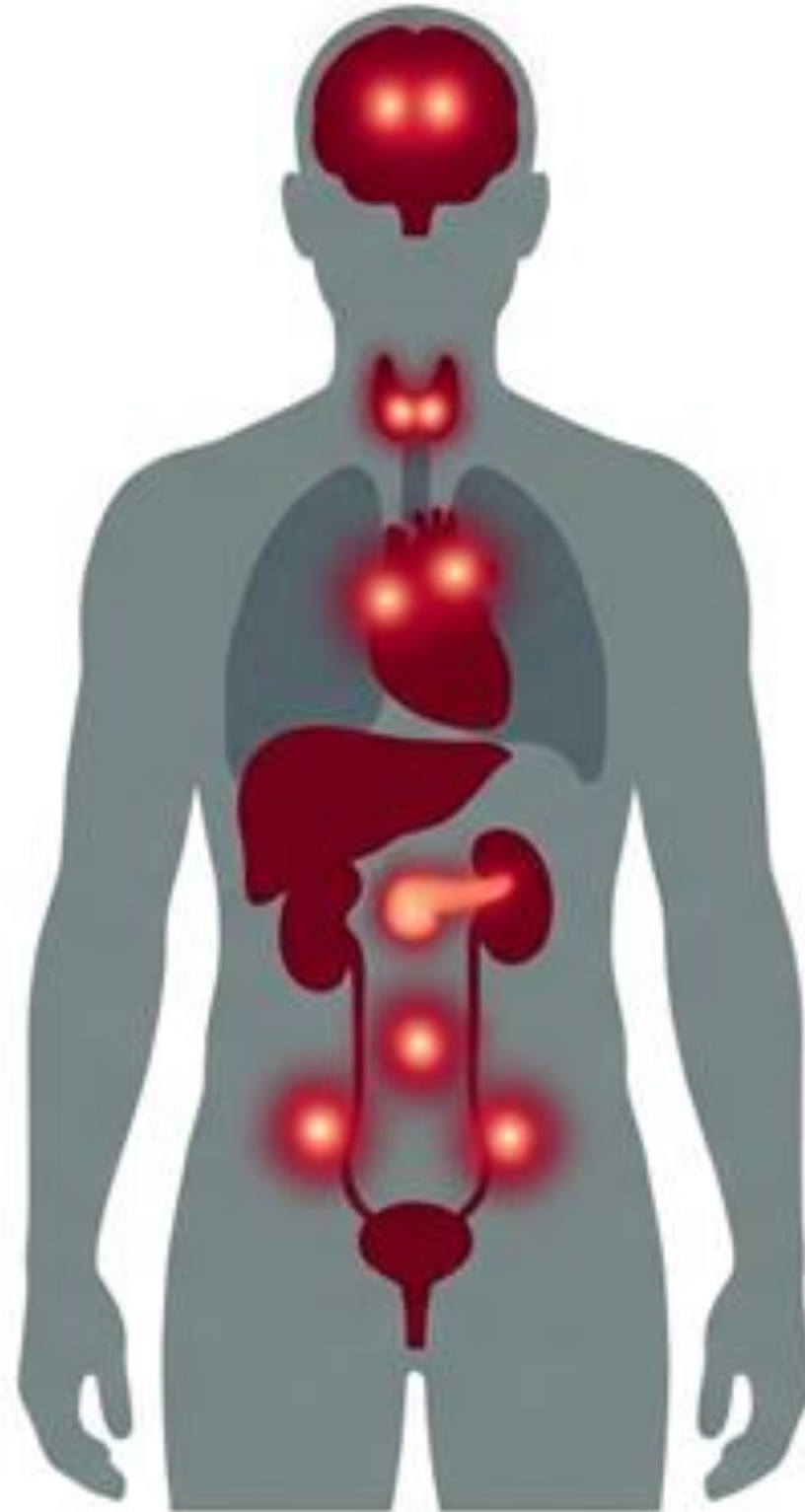
Mécanisme : Détecte l'hyper-consommation de glucose par les cellules cancéreuses.

Utilité : Bilan d'extension corps entier.

Scintigraphie Osseuse

Traceur : Technétium-99m.

Cible : Fixation sur les métastases osseuses.



Scintigraphie Thyroïdienne

Informations morphologiques et fonctionnelles spécifiques.

Diagnostic Endoscopique : Visualisation Directe



Méthodes d'Exploration :

- Organes creux : Fibroscopie, Coloscopie, Cystoscopie.
- Cavités fermées : Coelioscopie ou Laparoscopie.

Avantages Clés :

1. Visualisation directe de la lésion (aspect, ulcération).
2. Prélèvements biopsiques : Indispensable pour la preuve histologique.

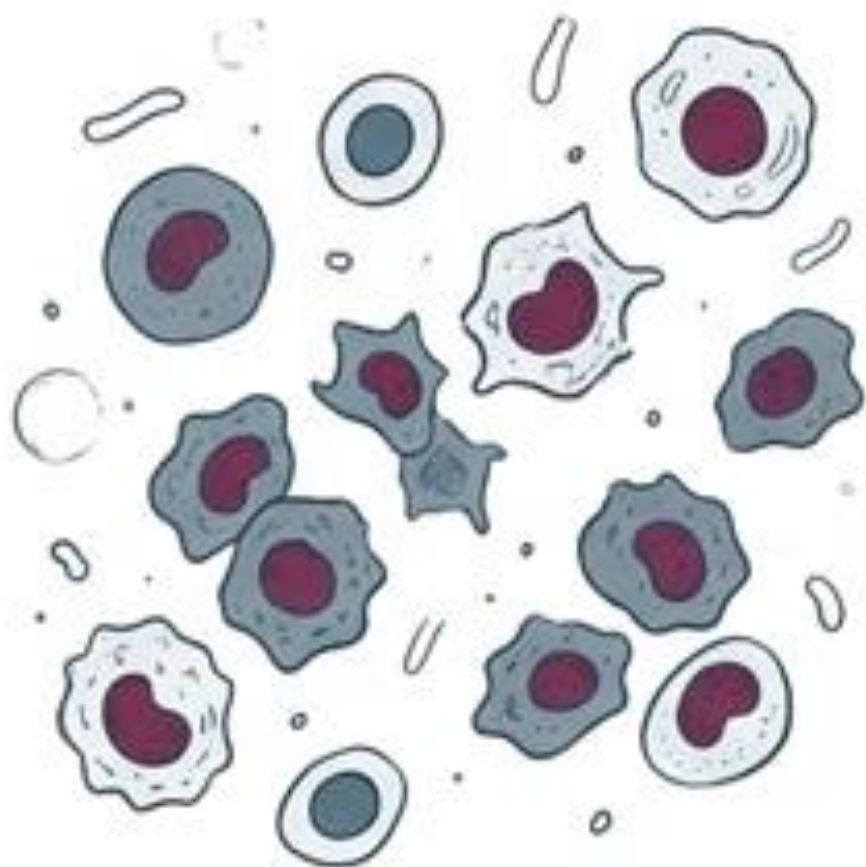
La Preuve Histologique : Le Gold Standard

Le diagnostic de certitude est TOUJOURS histologique.

- Connaissance histologique précise.

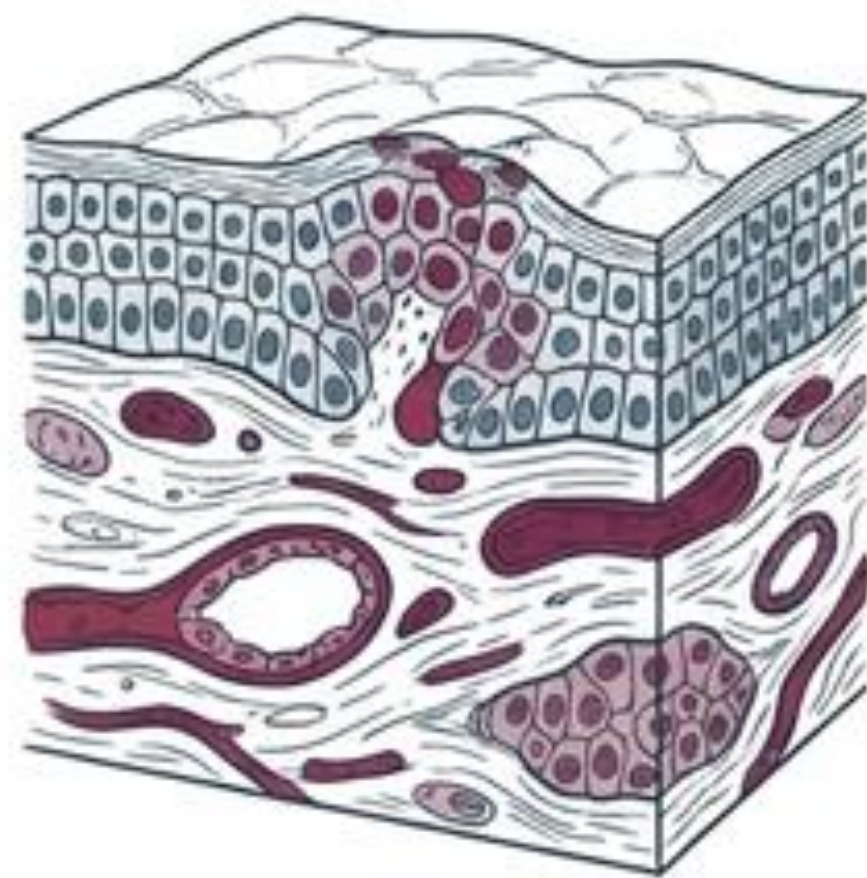
Cytologie (Cellules isolées)

- **Méthodes** : Frottis, Ponction (liquide pleural, ascite).
- **Limite** : Risque de faux négatifs. Pas d'architecture tissulaire.

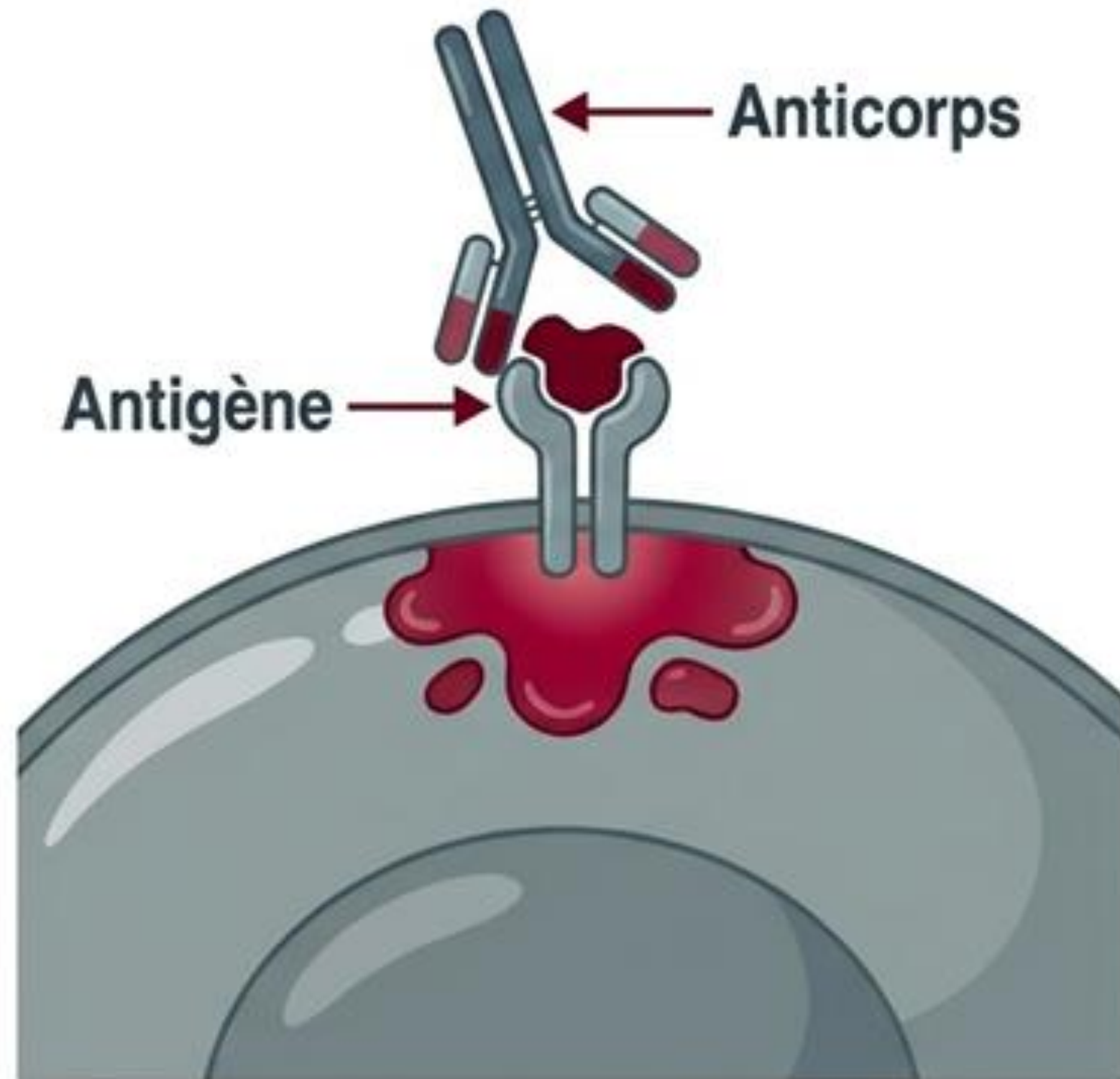


Histologie (Tissu)

- **Méthodes** : Biopsie (aiguille, pince) ou Pièce opératoire.
- **Objectif** : Analyse de l'architecture tissulaire et cellulaire.



Caractérisation Avancée : Immunohistochimie (IHC)



Définition : Technique visant à localiser une protéine spécifique dans un tissu.

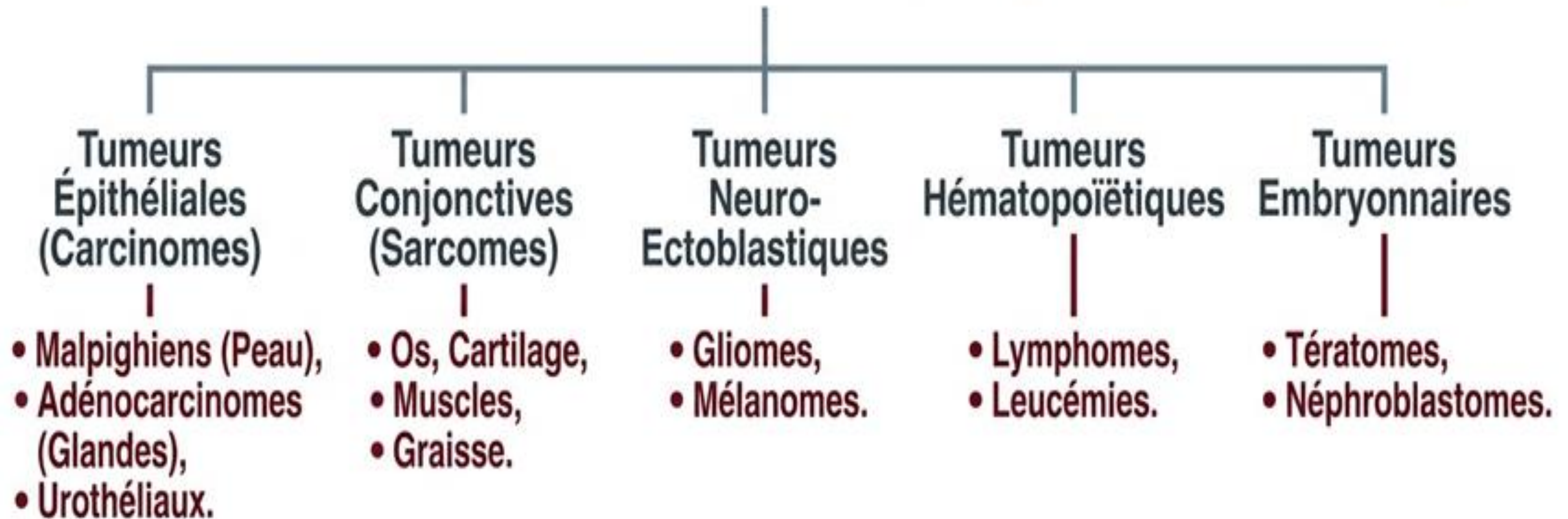
Principe :

- Réaction Antigène-Anticorps.
- Révélation chimique pour identification.

Indications Majeures :

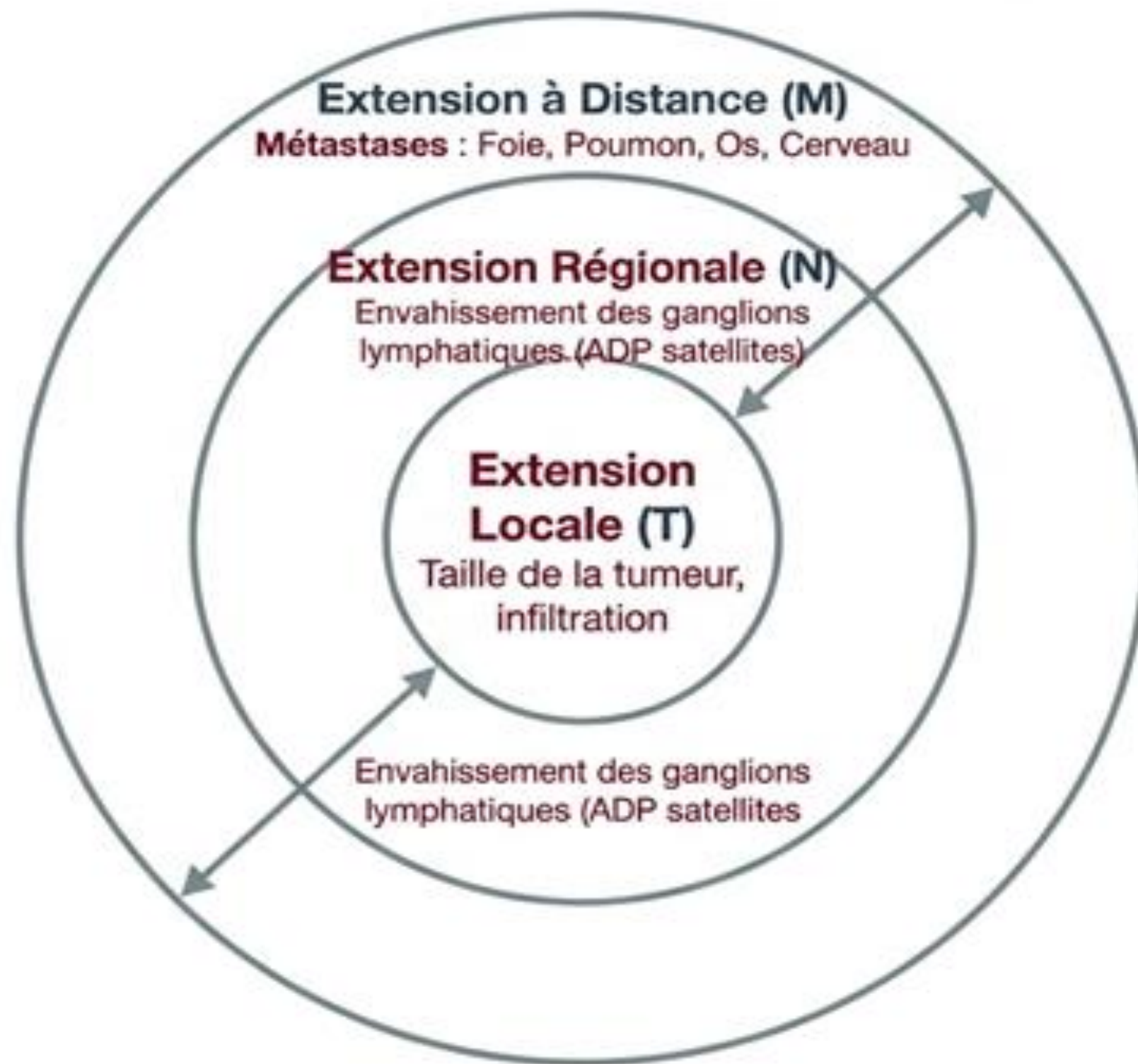
1. Catégoriser les tumeurs indifférenciées.
2. Détecter les récepteurs hormonaux (ex: **Sein**).
3. Identifier des **cibles thérapeutiques**.

Classification des Tumeurs (Origine Tissulaire)

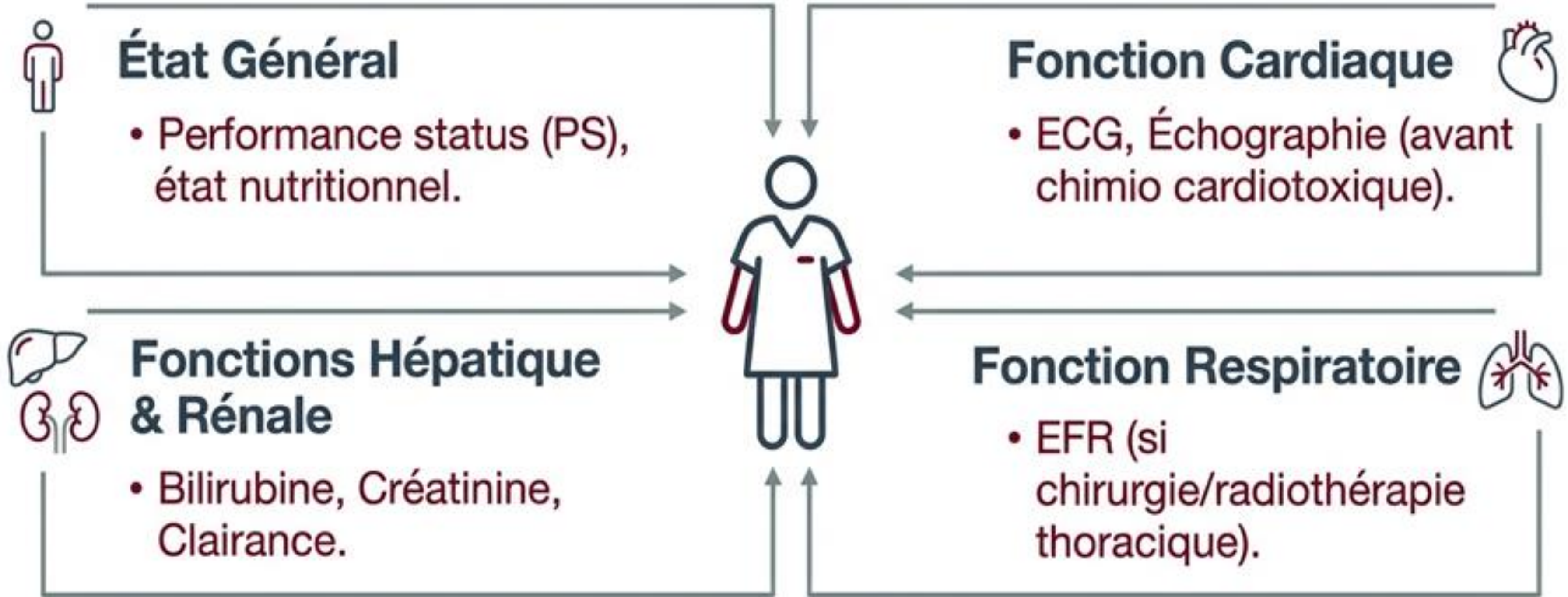


Le Bilan d'Extension : Évaluer la Gravité

Objectif : Définir l'étendue anatomique pour choisir le traitement.



Bilan Général et Fonctionnel : Évaluer le Patient



Pourquoi ? Apprécier la **tolérance aux futurs traitements**.

La Synthèse : La Classification TNM

Clinique + Radiologie + Histologie = Diagnostic de Certitude

T

TUMOR

Taille et
extension locale.

N

NODES

Envahissement
ganglionnaire
régional.

M

METASTASIS

Présence de
métastases à
distance.



**Stades
Pronostiques
(I, II, III, IV)**

Conclusion : Vers la Décision Thérapeutique



Le But Ultime :

Le diagnostic n'est qu'une étape.
L'objectif est la mise en route d'un
Projet Thérapeutique Concerté.

La Réunion de Concertation Pluridisciplinaire (RCP) :

- Chirurgiens
- Oncologues
- Radiothérapeutes
- Radiologues
- Pathologistes

Rigueur diagnostique = Traitement adapté = Meilleures chances de survie.

Le Parcours du Diagnostic en Oncologie : De la Découverte au Traitement

Le Diagnostic Positif (Affirmer le Cancer)



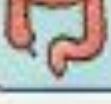
La Démarche Clinique et l'Alerte

Repérer les symptômes révélateurs (douleur, masse palpable) et les signes généraux (Asthénie, Anorexie, Amaigrissement).



L'Arsenal Paraclinique

Utiliser la biologie (marqueurs), l'imagerie (Scanner, IRM, TEP) et l'endoscopie pour localiser la lésion.

Exemples de marqueurs tumoraux		
	PSA	Cancer de la Prostate
	AFP	Carcinome Hépatocellulaire (Foie)
	ACE / CA 19.9	Cancers Digestifs



La Preuve Histologique : Le "Gold Standard"

Seul l'examen anatomopathologique (biopsie ou cytologie) apporte la certitude du diagnostic de cancer.

Le Bilan Pré-thérapeutique et Pronostique



Évaluer l'Extension de la Maladie

Analyser la taille locale, l'envahissement des ganglions régionaux et la présence de métastases.



Évaluation de l'État Général

Réaliser un bilan fonctionnel (hépatique, hématologique) pour vérifier l'aptitude du patient au traitement.



La Décision Thérapeutique Concertée

Synthétiser les données (TNM) pour établir un stade précis et un projet de soins.